EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72773
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 20-10-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NOELIA DEL CARMEN LANDERO SAN JUAN			RUN	: 4.401.141-7
F.Nac	: 11-03-2022	Edad	: 1 AÑO, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-16	Fecha Egreso	: 20-10-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R05.X-TOS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Hemorragia Digestiva Alta de PE UP - Blatchford 6 pts
-Anemia severa transfundida
-Gastropatía crónica
-IRB en tratamiento
-Hipertensión Arterial
-Insulinoresistencia ?
-Artrosis

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente refiere inicio de sintomatología hace 2 semanas aproximadamente presentando accesos de tos intermitente leve a moderada de predominio nocturno, en inicio seca, posteriormente con expectoración blanquecina/transparente. Destaca que se exacerba con actividad física. Asociada únicamente a leve dolor torácico opresivo. Niega disnea franca, odinofagia, cefalea, aumento de temperatura corporal o algún otro signo o síntoma asociado. Menciona que desde hace 2meses+ está presentando episodios de melena, constantemente con heces de color negruzco. Episodio similar hace 7 meses que requirió hospitalización además de EDA 15/03: gastritis erosiva cronica + Hernia Hiato. Impresiona que no se dio seguimiento al cuadro, sólo se suplementó con sulfato ferroso. Acude a urgencias donde se determina elevación franca de parámetros inflamatorios además de Hb 6.0, requiriendo transfusión de CR. En vista de condiciones, se decide ingreso a servicio para estudio y seguimiento.
Se realiza EDA con hallazgos de esofagitis erosiva péptica grado B, Hernia hiatal por deslizamiento, gastropatía difusa antro corporal de aspecto crónico. Refirió 2 deposiciones negras durante la hospitalización con tacto negativo para melena, heces marrones, Hb 8.3 sin nuevos requerimientos transfusionales, Se decide alta con HODOM para completar antibioticoterapia con Ceftriaxona por 7 días, tomar Colonoscopia 24/10/23 ambulatorio.

PLAN DE MANEJO:

HODOM para completar 7 dias de ceftriaxona por cuadro de infeccion respiratoria
KNT respiratoria
Regresar para Colonoscopia 24/10/23
Control en Poli Dr. Acero en 15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. OMEPRAZOL comp 20 MILIGRAMOS 1 frasco cada 24 hrs. por 30 dias via ENDOVENOSA
2. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 2 dias via ENDOVENOSA
3. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 3 días vía ORAL
4. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 2puff cada 8hr por 3 días
5. Fleet fosfosoda para preparación de colonoscopia

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO